طبع فى 19:48:37 11/10/2026

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ابراهيم احمد محمد ابراهيم

المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** شبرا **العنوان :** 2 ش عثمان بن عفان شبرا البلد

رقم البطاقة : 29705081400451 **رقم التليفون :** 01140648694 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 08-05-1997 **المهنة :** سائق

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : اورام ليمفاويه
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : اورام ليمفاويه
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي وتلطيفي [6396] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ابراهيم احمد محمد ابراهيم
National ID: 29705081400451

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of lymphoma for Supportive and palliative care with follow-up

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]
National ID – Front & Back





[[DOCTYPE:NON_HIO_LETTER]]
Non-HIO Letter

Ministry of Health and Population
El Salam Oncology Center

EL-SALAM ONCOLOGY CENTER

وزارة الصحة والسكان
الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام السلام

تقرير طبى

اسم المريض ثلاثيا / ابراهيم أحمد محمد

رقم الملف الطبى للمريض : ٤٤٤٣٠

السيد / .....

تحية طيبة وبعد

إيماءًا للكتاب رقم : ..... المؤرخ : ..... بشأن : .....

للمريض / ..... بقسم : ..... رقم طبى : .....

نتشرف بأن نوضح فيما يلى تقريرًا عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول : ..... تاريخ وساعة الخروج : .....

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه :

4 ARVD → ref. last 9/2023

3 ICE → ref last 26/11/20

3 GDP → ref last 20/3/2021

Th 2 Adcetr → Last 8/2025

Th Keytruda 6 cycl Lat 3/2026

PET +ve 5/5/2026

Now on Etoposid (50 mg)

for DHAP 3 cycl

تحريرًا فى : / / ٢٠٢

Y no resp

الطبيب المعالج

For Benda vs

يعتمد

As prof. Dr

Refaat Abdel Fattah order

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٧٩٣٤ س ٢٠٢٣ - ٥٠

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

Dr. Saad S. Eissa, M.D.
D d' Etat C E S Path (Paris). D.A.E. (Paris)
F.L.E.X. (Maryland, U S A)
Former Fellow Johns Hopkins Medical School
Member of Societe Anatomique de Paris
Member of International Academy of Pathology
Professor and chairman, Pathology department
National Cancer Institute, Cairo University

دكتور سعد سيد عيسى
دكتوراه باثولوجيا "باريس"
زميل الجمعية الباثولوجية الفرنسية
زميل بكلية طب جونز هوبكنز الأمريكية
عضو الأكاديمية الدولية الباثولوجية
استاذ ورئيس قسم التحاليل الباثولوجية والأورام
معهد الأورام – جامعة القاهرة

PATHOLOGY REPORT

Name: IBRAHIM AHMED MOHAMED IBRAHIM **Age:** *27 years*

Clinical picture: Cervical Lymphadenopathy

Nature of specimen: Excision Biopsy

Referred by: Prof. Dr. MOHAMED GAMIL **Date:** 15 / 12 / 2024

Gross:

Two cervical lymph nodes, ranging from 0.5x0.8 cm to 1x0.5 cm, embedded as such.

Microscopic:

Sections revealed lymph nodes with effacement of nodal architecture by pleomorphic cellular infiltrate rich in small lymphocytes, histiocytes and scattered mono and multinucleated large cells. No specific inflammatory granuloma.

Diagnosis:

CERVICAL LYMPH NODE EXCISION BIOPSY: ATYPICAL POLYMORPHIC INFILTRATE SUGGESTIVE OF HODGKIN'S LYMPHOMA. IMMUNOPHENOTYPING FOR CONFIRMATION AND SUBTYPING -AVAILABLE IN OUR LAB- IS REQUIRED (CD3, CD15, CD20 AND CD30).

(Code: 315 / 12 / 2024)

Date of issue: 18 / 12 / 2024

معمل ٦-١٢شارع بطرس غالي متفرع من إبراهيم اللقاني ميدان روكسي - مصر الجديدة - الدور الخامس شقة ٢٠
E-mail:drsaadeissa@hotmail.com
معمل ٢٧٩٥٥٦٩٢ - ٢٤٥٣٨٢٩٩

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

المعهد القومي للأورام
جامعة القاهرة

Patient Name:	ابراهيم احمد محمد ابراهيم	Location:	الباطنة عيادة
MRN:	123019936	Sex:	Male
D.O.B:	08/05/1997		
IC No.:	29700000000000		

Surgical Pathology-Diagnosis

Slide/Block revision Pathology

Specimen Id	2412291248	**Collection Date**	29/12/2024 01:52 PM
Accession No	P-24-16858	**Received Date**	29/12/2024 07:46 PM
Sample Type	TISSUE	**Doctor**	جيهر حضمي (أ ، ب) باطنة

CLINICAL HISTORY

Excisional biopsy of enlarged cervical lymph node. Patient is reported to have received treatment outside NCI for classic Hodgkin lymphoma and progressed.

GROSS DESCRIPTION

One paraffin block and one H&E stained slide labelled 315.

MICROSCOPIC DESCRIPTION

Lymph node showing complete effacement of the normal nodal architecture by polymorphic infiltrate composed of lymphocytes, plasma cells, histiocytes and esinophils admixed with many scattered large mono and binucleated cells having large vesicular nuclei and prominent nucleoli.

IMMUNOHISTOLOGY

- CD20 : stains reactive B-lymphocytes, negative in large cells.
- CD3: stains reactive T-lymphocytes
- CD30 : positive in the above described large cells.
- CD15 : positive in the above described large cells and granulocytes.
- MUM-1 : positive in the above decribed large cells.

COMMENT

DIAGNOSIS

Cervical lymph node, Referred:

Consistent with classic Hodgkin lymphoma.

Category

Malignant primary site (single tumor)

[[DOCTYPE:LAB_TEST]]
lab test

وزارة الصحة
المراكز الطبية المتخصصة
مركز علاج الاورام- مدينة السلام
القاهرة

El - Salam Oncology Center

Patient Name	: ابراهيم احمد محمد	Lab No.	: 3128361
Patient No	: 44432	Request Date	: 29-09-2026 11:53
Sex	: Male Age : 52 Y	Verification Date	: 29-09-2026 12:38
Financial Cat	: السلام-نفقة	Sample Type	: EDTA Blood
Department	: Out Patient	Test Status	: Routine
Referring Doc	:	Analyzers	: Celtaca_Salam

Complete Blood Picture

Test	Result	Unit	Ref. Range
Hemoglobin	**8.4**	g/dL	12.0 - 16.0
RBCs	**3.6**	10^6/uL	4.0 - 6.5
Haematocrit (PCV)	**29.2**	%	36.0 - 50.0
MCV	80.7	FL	76.0 - 101.0
MCH	**23.2**	pg	26.0 - 32.0
MCHC	**28.8**	g/dL	31.5 - 34.5
RDW-CV	**17.3**	%	11.6 - 14.0
PLT	258	10^3/ul	150 - 450
WBCs.Total	**12.2**	10^3/uL	4.0 - 11.5

Differential Leucocytic Count :

	Relative		Absolute			
Neutrophils%	76.6	%	**9.35**	/cmm	2.00 -	7.00
Lymphocytes%	18.7	%	2.28	/cmm	1.50 -	3.50
Monocytes %	4.7	%	0.57	/cmm	0.20 -	1.00

Signature

Hend Ekram

العنوان : مدينة السلام – طريق بلبيس – أول طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
ت : 22797921 & 22797923 & 22797925 فاكس : 22797928 E-mail/SOC Link , Net

[[DOCTYPE:LAB_TEST]]
lab test

وزارة الصحة
المراكز الطبية المتخصصة
مركز علاج الاورام- مدينة السلام
القاهرة

Patient Name	ابراهيم احمد محمد	Request No	3128361
Patient No	44432	Request Date	29-09-2026 11:53
Sex	Male	Verification Date	29-09-2026 12:52
Age	52 Y	Sample Type	Serum
Financial Cat	السلام-نفقة	Test Status	Routine
Department	Out Patient	Analyzers	VITROS350_S
Referring Doc			

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Ref. Range
Liver Functions			
Alkaline phosphatase	**188.0**	U/l	38.0 - 126.0)
Bilirubin Direct	0.30	mg/dl	Up to 0.30)
Bilirubin Total	**1.50**	mg/dl	0.20 - 1.30)
AST (SGOT)	29.0	U/l	14.0 - 59.0)
ALT (SGPT)	11.0	U/l	10.0 - 50.0)
Albumin	3.6	g/dl	3.5 - 5.0)
Total proteins	6.4	g/dl	6.3 - 8.2)
Serum Creatinine	0.6	mg/dl	0.6 - 1.2)
Serum Sodium (Na)	136.2	mmol /l	136.0 - 148.0)
Serum Potassium (K)	3.8	mmol/l	3.5 - 5.2)
Serum Calcium (Ca)	8.9	mg/dl	8.4 - 10.2)
Uric acid	6.7	mg/dl	2.5 - 8.5)
Urea	**43.6**	mg/dl	15.0 - 42.9)

Signature

اسراء جلال محمد

العنوان : مدينة السلام – طريق بلبيس – أول طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي
ت : 22797921 & 22797923 & 22797925 فاكس : 22797928 E-mail/SOC Link . Net

[[DOCTYPE:PET_SCAN]]
PET Scan

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
Oncology Center
خطابات اورام
Nasser Institute Hospital

Patient Name : ابراهيم احمد محمد *Date: 05/05/2026*

Referring Physician: Prof. Dr.

Whole body PET/CT

Technique:-

Approximately one hour following the IV injection of the radiopharmaceutical, a total body PET – CT was acquired from mid thigh to base of skull with the arms extended above the head. CT was acquired for the purpose of anatomic localization & attenuation correction. Data was processed & displayed according to departmental protocol.

Report:

Follow up PET/CT study for a known case of lymphoma, compared to the previous pet/ct examination dated 03/01/2026, the current scan revealed:

Hepatic Reference: max SUV ~3.4.

Head & Neck:

- *Rather stationary size , course , with ,mild increased FDG activity , of the today's still seen bilateral upper deep cervical , submandibular , lower deep cervical,, level V b , C , supra-clavicular nodal lymphomatous lesions(the Rt sided supraclavicular nodal lymphomatous lesions) measuring 2.2 X 2.4cm) is the most prominent , with max SUV~ 13.1) , (compared to the last study max SUV ~10) , .*
- *The brain exhibited normal FDG bio-distribution.*
- *Physiologic FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands & larynx.*
- *No focal diffuse thyroid gland FDG uptake could be elicited.*

Chest:

- *Still seen with rather stationary course of the today's still seen bilateral lungs , metastatic lymphomatous pulmonary masses , & nodules , , the most prominent , is seen at RT upper lobe , measuring 2.4 x 2.6 Cm , with max SUV~10.4 , with still seen Rt apico-posterior patchy lesion , with air bronchogram , , (max SUV~ 7) , for follow up*

1351 Korniesh El Nile Aghakhan Shoubra Cairo Tel. 22039164 22039356 Fax 22039 236

[[DOCTYPE:PET_SCAN]]
PET Scan

Patient Name : ابراهيم احمد محمد **Date: 05/05/2026**
Referring Physician: Prof. Dr.

- *Mild progressive metabolic course of the today's still seen , multiple metabolically active FDG avid mediastinal & bilateral hilar nodal lymphomatous lesion (all groups) , including the internal mammary , peri-cardiophrenic , (the subcarinal , , and the lower pericardiopherenic nodal amalgam , , is the largest & most active is seen measuring 5.1 X 5.2 Cm , with max SUV~ 16.1) (compared to the last study 4.1 X 2.6 cm , with max SUV~ 11) , for follow up ..*
- *Progressive metabolic course , with rather stationary size , texture , of the today' s still seen RT subpectoral . . Rt axillary . multiple metabolically active FDG avid nodal lymphomatous lesion , measuring up to (1.6cm) with max SUV~ 15.5) , (compared to the lasts study , 1.6 cm , with max SUV~ 8) , for follow up .*
- *Physiologic FDG uptake is noted in the myocardium.*

Abdomen & Pelvis:

- *Still seen hepatomegaly with normal FDG uptake & no metabolically active FDG avid focal lesions.*
- *Progressive course of the today's still seen mild splenomegaly with scattered metabolically active FDG avid multiple splenic focal lesions, up to (2.8x2.4cm) with max. SUV~ 20.2) compared to the last study (2cm) with max. SUV~ 8) , for follow up.*
- *Rather stationary metabolic course of the today's still seen abdominal, pelvic nodal lymphomatous lesion (all groups (discrete & amalgamated) the largest is seen at left external iliac L.Ns (4.1x4.3cm) with max. SUV~ 17) with stationary size, (compared to the last study , with max. SUV~ 17.1), for follow up .*
- *Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys & bladder.*

1351 Kornlesh El Nile Aghakhan Shoubra Cairo Tel. 22039164 22039356 Fax 22039 236

[[DOCTYPE:PET_SCAN]]
PET Scan

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى ناصر
Nasser Institute Hospital

Oncology Center
خطابات أورام

Patient Name : ابراهيم احمد محمد
Referring Physician: Prof. Dr.
Date: 05/05/2026

Musculoskeletal:

- *Progressive course of the today's still seen metabolically active FDG avid wide spread osseous lesions (lymphomatous) are seen at (right humerus , RT scapulae , bilateral ribs , , multiple cervical , dorso-lumbar vertebrae , spine , pelvic bones , sacrum , both femora) , (max SUV~ 19.4) . (compared to the last study max SUV~ 11.1) , for follow up .*
- *Normal FDG activity is seen along the rest of surveyed skeleton. No sclerotic or lytic lesions are noted on CT.*

OPINION:

- ***Follow up PET/CT study shows:***
- ***Progressive course of the disease, as mentioned , for follow up (DS 5).***

Thank you for your reference.

PET/CT Unit

Nuclear Medicine Department

DR/Sherien Mahdy /, MD

Radiology Department

DR/ Ahmed Tohamy/,MD

Revised by

DR/ Mohamed Emam

١٣٥١ كورنيش النيل - اغاخان - شبرا - القاهرة ت: ٢٢٠٣٩١٦٤ - ٢٢٠٣٩٣٥٦ فاكس: ٢٢٠٣٩٢٣٦
1351 Kornlesh El Nile Aghakhan Shoubra Cairo Tel. 22039164 22039356 Fax 22039 236